

HABILIDADES CIRÚRGICAS



MONITORIA DE TOCE

Revisão Flash • SESSÃO 07

Neoplasias Digestivas e Ostomias

O essencial para a prova em uma página



Técnica Operatória e Cirurgia Experimental

UnibH Vespasiano

8º PERÍODO • 2026.2

Elaborado por JOÃO BATISTA FERNANDES JÚNIOR • *Monitor de TOCE*

Material de apoio da monitoria. Não substitui as aulas, os slides nem as referências indicadas pela disciplina.

Neoplasias digestivas e ostomias

Leitura de 5 minutos

EM UMA FRASE

Suspeite pelo sintoma, confirme com biópsia, estadie (TC; ecoendoscopia no esôfago e no estômago; RM no reto), trate pelo estágio e, se houver estomia, demarque antes e proteja a pele.

- | | |
|---|---|
| <p>1 Esôfago: escamoso = tabaco e álcool, terço médio; adeno = Barrett e obesidade, distal.</p> | <p>2 Esôfago avançado: neoadjuvância + esofagectomia; escamoso cervical = QRT definitiva.</p> |
| <p>3 Estômago: <i>H. pylori</i>; Lauren intestinal × difuso (anel de sinete, linite).</p> | <p>4 Gastrectomia: margem 3 cm (expansivo) ou 5 cm (infiltrativo); D2 se cT2+ ou N+.</p> |
| <p>5 SUS 2026: FIT de 50 a 75 anos em assintomáticos; positivo → colonoscopia.</p> | <p>6 Direito: anemia e massa. Esquerdo: obstrução. Reto: tenesmo.</p> |
| <p>7 Reto T3–T4 ou N+: RM, neoadjuvância e excisão total do mesorreto.</p> | <p>8 Reto médio ou baixo obstruído: derivar, não ressecar na urgência.</p> |

ESTOMIAS

TIPO	LADO · EFLUENTE
<i>Colostomia</i>	Esquerda · pastoso a sólido
<i>Ileostomia</i>	Direita · líquido, protrusa
<i>Urostomia</i>	Direita · urina

PEGADINHA

Estoma normal é vermelho e úmido; escuro é isquemia. Recorte largo da placa causa dermatite. Pó trata pele úmida; pasta veda desnível.

CHECKLIST ANTES DA PROVA

- ☐ Diferencio escamoso de adenocarcinoma
- ☐ Sei Lauren, Borrmann e os epônimos
- ☐ Sei margem e D2 do gástrico
- ☐ Sei o rastreamento colorretal no SUS
- ☐ Separo cólon e reto no tratamento
- ☐ Sei a conduta na obstrução
- ☐ Sei demarcar e trocar a bolsa